

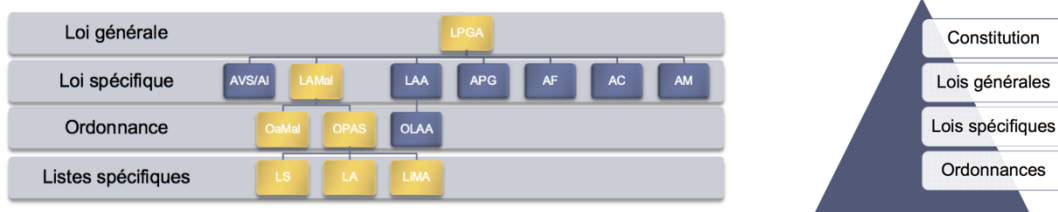
Assécurologie

A. Assurance maladie

Estelle W., 29 ans, déprimée chaque automne, pense que cela a un lien avec la diminution saisonnière de la luminosité, s'est sentie mieux l'année passée avec un appareil de luminothérapie prêté par son amie. Elle souhaite que vous lui en prescriviez un. L'assurance paie-t-elle ce traitement ?

Pierre T. a été victime d'un accident de chantier en 2006 avec une fracture de la jambe, ostéosynthèse sans complication. Il a toujours mal et ne peut toujours pas travailler. L'assurance accident cesse le paiement des soins en 2010 sans reconnaître d'invalidité. Il est révolté et vous demande votre appui. Que faites-vous ? Que va-t-il devenir ?

La base des lois c'est **la constitution** (fixation des règles grossières, modifié par le peuple), puis on a **des lois générales** (modifié par le parlement), **des lois spécifiques et des ordonnances** (modification par le Conseil Fédéral). La modification de chacun de ces étages se fait par des entités spécifiques.



La loi générale c'est **la LPGA** (loi sur la partie générale du droit des assurances sociales) qui donne les grosses définitions. Ensuite, on a des lois spécifiques, dont **la LAMal** et chacune de ces lois spécifiques a des ordonnances. **La OaMal et la OPAS** (ordonnance sur l'assurance maladie et ordonnance sur la prise en charge des soins) découlent directement de la LAMal. Finalement, à partir de la OPAS, on obtient les listes spécifiques suivantes : **LS, LA et LiMA** (respectivement liste de spécialités, liste des analyses et liste des moyens et appareils).

1. Définition et incapacités

L'incapacité de travail correspond à une perte, **totale ou partielle**, de l'aptitude à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui si cette perte résulte d'une **atteinte à sa santé psychique, mentale ou physique**.

L'incapacité de gain est une notion **purement économique** qui est définie par une diminution des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique, et qu'elle **persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles**.

Finalement, **l'invalidité** correspond à une incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Attention, cette notion n'est pas médicale mais **uniquement juridique**.

Pour un **mineur** sans activité lucrative, on le qualifie d'invalidé s'il présente une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle. Pour un **majeur** qui n'exerçait pas d'activité lucrative avant d'être atteint dans sa santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'il en exerce une, on le dit invalidé si l'atteinte l'empêche d'accomplir ses travaux habituels.

NB. Dans l'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.

2. Assurance maladie

La LAMal vise à **protéger contre les conséquences économiques d'une maladie ou d'une maternité**. Elle est **obligatoire** et assure **toutes les personnes domiciliées en Suisse**. L'assurance est faite par les caisses maladies reconnues comme telles **sans critères médicaux d'admission**. Elle couvre la maladie, la maternité et les accidents (si absence d'autres couvertures). L'OaMal et la OPAS sont les deux ordonnances qui découlent de la LAMal.

La maladie correspond à **toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique** qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail. On parle d'**infirmité congénitale** pour toute maladie présente à la **naissance** de l'enfant.

2.1 Qui est assuré ?

Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, **dans les trois mois** qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse (exception pour les missions diplomatiques). L'obligation de s'assurer est même obligatoire pour toutes les personnes non-domiciliées en Suisse mais qui y séjournent ou y exercent une activité régulièrement. En revanche, elle est **suspendue** si la personne est soumise à l'assurance militaire plus de 60 jours consécutifs.

Les assureurs autorisés sont établis selon une liste et doivent assurer tout le monde, sans filtre .

La durée de la couverture de l'assurance débute dès la naissance/début du domicile en Suisse et prend fin avec l'obligation d'être assuré (décès, départ de la Suisse).

2.2 Prestations maladies accidents

L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent **à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles**. Ces prestations comprennent :

- Les **examens, traitements et soins** dispensés sous forme ambulatoire, au domicile du patient, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social par **des médecins des chiropraticiens ou des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat médical** (psychologues, ergothérapeutes, sage-femme)
- Les **analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques** prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées, par un chiropraticien
- Une participation aux frais **des cures balnéaires** prescrites par un médecin : les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin, le séjour à l'hôpital (division commune), le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance
- Une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage
- Les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits.

a. Prestations et prévention

L'assurance obligatoire des soins prend en charge **les coûts de certains examens destinés à détecter à temps les maladies ainsi que des mesures préventives en faveur d'assurés particulièrement menacés**. Ces examens ou mesures préventives sont effectués ou prescrits **par un médecin**. En cas d'infirmité congénitale **non-couverte** par l'assurance-invalidité, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie.

b. Prestations et maternité

L'assurance obligatoire des soins **prend en charge les prestations spécifiques de maternité**. Ces prestations comprennent les **examens de contrôle**, effectués par un médecin ou une sage-femme ou prescrits par un médecin, pendant et après la grossesse, **l'accouchement** à domicile, dans un hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que l'assistance d'un médecin ou d'une sage-femme, les conseils nécessaires en cas

d'allaitement, les soins accordés au nouveau-né **en bonne santé** et son séjour, tant qu'il demeure à l'hôpital avec sa mère.

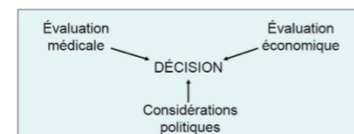
c. Prestations divers

En cas **d'interruption de grossesse** (non-punissable au sens du code pénal), **l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations que pour la maladie**. Par défaut, **les soins dentaires ne sont pas pris en charge**, sauf s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non-évitables du système de la mastication, par une autre maladie grave ou ses séquelles, s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles ou si les coûts du traitement de lésions du système de la mastication ont été causées **par un accident**.

2.3 Conditions de prise en charge

Les prestations doivent être **efficaces, appropriées et économiques**. L'efficacité doit être démontrée selon des **méthodes scientifiques** (réexamen périodique). Le Conseil Fédéral établit une **liste contraignante** (fermée) des prestations dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation.

La LAMal contient en fait un catalogue des prestations qui seront financées collectivement. La décision pour savoir si un élément entrera ou non dans le catalogue est discutée selon trois points de vue : **évaluation médicale, évaluation économique et considérations politiques**.



A l'OFSP, il existe **une commission fédérale** des principes de l'assurance maladie, commission qui est elle-même sous-divisée en quatre catégories :

- **OPAS** : catalogue de prestations mis à jour régulièrement dans l'ordonnance de prise en charge des soins (par exemple nutrition, vaccins)
- **LA** : liste des analyses
- **LiMA** : liste des appareils et moyens à charge de l'assurance (photothérapie payée si dépression saisonnière prouvée)
- **LS** (liste des spécialités) : liste **exhaustive** des médicaments admis à charge de l'assurance, parfois indications de conditions particulières de prise en charge

La liste des **professionnels** qui peuvent pratiquer à la charge de l'assurance maladie **est une liste fermée**.

2.4 Où puis-je me faire traiter ?

En cas de traitement **ambulatoire**, il y a un **libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie**. L'assureur prend en charge les coûts jusqu'à concurrence du tarif applicable au lieu de résidence ou de travail de l'assuré ou dans les environs.

En cas de traitement **hospitalier**, il y a **également le libre choix entre les hôpitaux aptes à traiter sa maladie et figurant sur la liste de son canton de résidence ou celle du canton où se situe l'hôpital**. En cas de traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l'assureur et le canton de résidence prennent en charge leur part respective de rémunération jusqu'à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de résidence.

L'obligation d'admission signifie que, dans les limites de leurs mandats de prestations et de leurs capacités, **les hôpitaux répertoriés sont tenus de garantir la prise en charge de tous les assurés résidant dans le canton où se situe l'hôpital**.

2.5 Financement

Le financement se fait d'après le système de la répartition des dépenses. Les assureurs constituent des réserves suffisantes afin de supporter les coûts afférents aux maladies déjà survenues et de garantir leur solvabilité à long terme. Le financement **doit être autonome**. Les assureurs présentent séparément au bilan les provisions et les réserves destinées à l'assurance obligatoire des soins. Les assureurs tiennent **un compte d'exploitation** pour l'assurance obligatoire des soins qui est distinct des assurances complémentaires (assurances du domaine privé et non pas du domaine de l'assurance sociale).

a. Primes

L'assureur **fixe le montant des primes** à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés. L'assureur peut **échelonner** les montants des primes s'il est établi que les coûts diffèrent selon les cantons et les régions. Le lieu de résidence de l'assuré est déterminant (différence région Léman et reste du Canton de Vaud). L'office délimite les régions uniformément pour tous les assureurs. Pour les assurés de moins de 18 ans révolus (enfants), l'assureur **est obligé de fixer une prime plus basse** que celle des assurés plus âgés (adultes). Il est **autorisé à le faire** (possibilité) pour les assurés de moins de 25 ans révolus (jeunes adultes).

b. Formes particulières d'assurance

L'assureur peut **réduire les primes des assurances** en contrepartie d'un choix limité du fournisseur de prestations. Le Conseil fédéral peut autoriser la pratique d'autres formes d'assurance, notamment celles dans lesquelles l'assuré qui consent à une **participation aux coûts plus élevée** que celle qui est prévue à l'art. 64 bénéficie en contrepartie d'une réduction de prime (franchise).

Les primes des adultes sont les suivantes : 300.-, 500.-, 1000.-, 1500.-, 2000.-, 2500.-, tandis que les primes des enfants sont équivalentes à 0.-, 100.-, 200.-, 300.-, 400.-, 500.- et 600.-. Le montant de la prime de l'assuré dépend de la question de savoir si, pendant une certaine période, il a bénéficié ou non de prestations.

c. Participation aux coûts

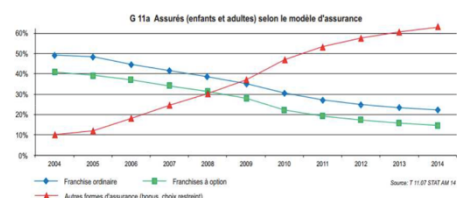
Les assurés **participent aux coûts** des prestations dont ils bénéficient. Leur participation comprend un une franchise (montant **fixe** par année, adulte à 300.-, aucune franchise obligatoire pour un enfant) et 10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part, plafonnée à 700.- pour un adulte et 350.- pour un enfant). Plusieurs enfants d'une même famille, assurés par le même assureur, payent ensemble au maximum le montant de la franchise et de la quote-part due par un adulte. En cas **d'hospitalisation, la contribution aux frais de séjour est de 15.-** (pour la nourriture, sauf enfants, maternité).

Le **Conseil fédéral** peut prévoir une participation aux coûts plus élevée pour certaines prestations, réduire ou supprimer la participation aux coûts des traitements de longue durée et du traitement de maladies graves, ou encore supprimer la franchise pour certaines mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal. L'assureur **ne peut exiger** aucune participation s'il s'agit de prestations **en cas de maternité**.

d. Réduction des primes par les pouvoirs publics

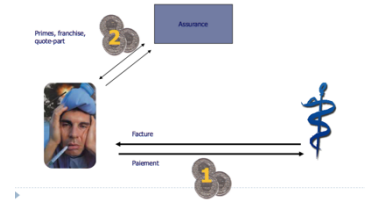
Les cantons accordent des réductions de primes **aux assurés de condition économique modeste**. Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de **50 % au moins les primes des enfants et des jeunes adultes en formation**. Dans ce but, la **Confédération** accorde à chaque canton **des subsides annuels** correspondant à 7.5% des coûts bruts de l'assurance obligatoire des soins.

La franchise à option et la franchise ordinaire ont tendance à diminuer, tandis que les autres formes d'assurance sont en augmentation.



2.6 Tiers garant-tiers soldant

Le tiers est l'assureur et le binôme correspond à l'association médecin/patient. Le tiers est généralement **garant**, c'est à dire **qu'il nous rembourse ce qu'il nous doit**. Dans le tiers **payant**, le médecin envoie directement la facture aux assureurs. L'assureur paie le médecin et envoie la facture au patient pour qu'il puisse lui payer ce qui lui est dû.



Sauf convention contraire entre les assureurs et les fournisseurs de prestations, **l'assuré est le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations**. L'assuré a, dans ce cas, le droit d'être remboursé par son assureur (système du tiers garant). Ce droit peut être cédé au fournisseur de prestations. Assureurs et fournisseurs de prestations peuvent convenir que l'assureur est le débiteur de la rémunération (système du tiers payant).

a. Facturation

Le fournisseur de prestations doit remettre au débiteur de la rémunération **une facture détaillée et compréhensible**. Il doit aussi lui transmettre **toutes les indications nécessaires** lui permettant de vérifier le calcul de la rémunération et **le caractère économique** de la prestation. Dans le système du tiers **payant**, l'assuré reçoit **une copie** de la facture qui a été adressée à l'assureur. **L'assureur peut exiger** un diagnostic précis ou des renseignements supplémentaires d'ordre médical. Le fournisseur de prestations (~le médecin) peut lorsque les circonstances l'exigent, ou **est astreint dans tous les cas si l'assuré le demande**, à ne fournir les indications d'ordre médical **qu'au médecin-conseil de l'assureur**.

2.7 Changement d'assurance

Le changement d'assurance est **possible avec un préavis de 3 mois pour chaque semestre**. Lors de la communication de la nouvelle prime, on peut changer d'assureur **pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la nouvelle prime** (préavis d'un mois). L'assureur doit annoncer à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l'Office fédéral de la santé **publique au moins deux mois à l'avance et signaler à l'assuré qu'il a le droit de changer d'assureur**.

⇒ En pratique, au mois d'octobre l'assureur annonce les primes (presse, puis annonce personnelle) et le délai de résiliation est généralement fixé à fin novembre.

L'affiliation auprès de l'ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu'il assure l'intéressé **sans interruption de la protection d'assurance**. Lorsque l'assuré change d'assureur, l'ancien assureur **ne peut le contraindre** à résilier également les assurances complémentaires conclues auprès de lui.

a. Suspension possible de la couverture accident

La **couverture accident** peut être suspendue si la personne est **assurée par l'assurance accident obligatoire LAA**. Un faible pourcentage de la prime totale représente la couverture accident. **L'employeur** informe par écrit la personne qui quitte son emploi ou cesse d'être assurée contre les accidents non-professionnels au sens de la LAA **qu'elle doit le signaler à son assureur au sens de la présente loi** (même obligation pour l'assurance chômage lorsque le droit aux prestations de cette institution expire sans que l'intéressé prenne un nouvel emploi). Si l'assuré n'a pas demandé la reprise de la couverture accident, **l'assureur peut en exiger le paiement a retro**.

2.8 Caisses maladies

Les caisses maladies sont des personnes juridiques de droit privé ou public **sans but lucratif** qui gèrent principalement **l'assurance maladie sociale** et qui sont reconnues par le Département fédéral de l'intérieur. Les caisses-maladie **ont le droit de pratiquer des assurances complémentaires**, en plus de l'assurance-maladie sociale et elles peuvent également pratiquer d'autres branches d'assurance (régies selon la loi sur le contrat d'assurance).

La liste des caisses maladies est établie par l'OFSP et les assureurs doivent remplir les conditions suivantes :

- Pratiquer l'assurance-maladie sociale selon **le principe de la mutualité, garantir l'égalité de traitement** des assurés et n'affecter qu'à des buts d'assurance-maladie sociale les ressources provenant de celle-ci
- Disposer d'une organisation et pratiquer une gestion qui garantissent le respect des dispositions légales
- Être en mesure de **remplir leurs obligations financières en tout temps**
- Pratiquer **également l'assurance individuelle d'indemnités journalières** conformément à la présente loi
- Avoir **un siège en Suisse**

a. Promotion de la santé

Les assureurs encouragent la prévention des maladies. Ils gèrent en commun avec les cantons une institution dont le but est de stimuler, coordonner et évaluer des mesures destinées à **promouvoir la santé et à prévenir les maladies**. L'organe directeur de l'institution est composé de représentants des assureurs, des cantons, de la CNA, de la Confédération, des médecins, des milieux scientifiques ainsi que des organisations spécialisées dans la prévention. L'assurance maladie est financée par une contribution prélevée sur les primes d'assurance, sous la surveillance de l'OFSP.

b. Surveillance

L'assurance maladie de base est surveillée par l'OFSP (Conseil Fédéral), tandis que **les assurances complémentaires privées** sont surveillées par la FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers). L'OFSP peut requérir des assureurs **tous les renseignements et les documents nécessaires** et procéder à des inspections (sans avoir été annoncées). Les assureurs doivent accorder à l'office **le libre accès à toutes les informations** qu'il juge pertinentes dans le cadre de l'inspection. Ils doivent lui communiquer leurs rapports et leurs comptes annuels. Les assureurs doivent communiquer chaque année à l'office les données concernant la facturation des prestations et l'activité d'assurance.

Les assureurs doivent **limiter les frais d'administration** de l'assurance maladie sociale aux exigences d'une gestion **économique**. L'Office fédéral de la statistique établit les bases statistiques nécessaires à l'examen du fonctionnement et des effets de la présente loi. Il collecte auprès des assureurs, des fournisseurs de prestations et de la population les données nécessaires à cet effet.

c. Médecin Conseil

Les assureurs désignent des médecins-conseils. Ils doivent **avoir pratiqué dans un cabinet médical** (> 5 années de pratique). Le choix est en accord avec la société médicale cantonale. Le médecin-conseil donne son avis à l'assureur sur des questions médicales ainsi que sur des questions relatives à la rémunération et à l'application des tarifs. Il examine en particulier **si les conditions de prise en charge d'une prestation sont remplies**. Il doit évaluer les cas en toute indépendance. Ni l'assureur ni le fournisseur de prestations ni leurs fédérations ne **peuvent lui donner de directives**.

Les fournisseurs de prestations doivent donner aux médecins-conseils les indications dont ils ont besoin. Celui-ci peut **examiner lui-même l'assuré**. Les médecins-conseils ne transmettent aux organes compétents des assureurs que les indications dont ceux-ci ont besoin pour décider de la prise en charge d'une prestation, pour fixer la rémunération ou motiver une décision. Ce faisant, ils respectent les droits de la personnalité des assurés.

d. Contrôles de qualité

Les contrôles de qualité sont des contrôles scientifiques et systématiques pour garantir **la qualité ou l'adéquation des prestations que l'assurance obligatoire des soins prend en charge**.

L'exécution est confiée **aux associations professionnelles** ou à d'autres institutions (exemple du laboratoire du médecin) et elle permet de déterminer les mesures servant à garantir ou à rétablir la qualité ou l'adéquation des prestations. Il peut en particulier prévoir que l'accord du médecin-conseil est nécessaire avant l'exécution de certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques, notamment celles qui sont particulièrement coûteuses et que des mesures diagnostiques ou thérapeutiques particulièrement coûteuses ou difficiles ne seront prises en charge par l'assurance obligatoire des soins que lorsqu'elles sont pratiquées par des fournisseurs de prestations qualifiés en la matière. Il peut désigner ces fournisseurs de prestations

Le manquement aux exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations correspond aux situations suivantes :

- Non-respect du caractère économique des prestations
- Inexécution ou mauvaise exécution du devoir d'information
- Obstruction aux mesures de garantie de la qualité
- Non-répercussion d'avantages, manipulation frauduleuse de décomptes ou la production d'attestations contraires à la vérité.

Les conséquences potentielles sont un **avertissement**, une **restitution de tout ou d'une partie des honoraires touchés pour des prestations fournies de manière inappropriée**, une amende, voire même une exclusion temporaire ou **définitive** de toute activité à la charge de l'assurance obligatoire des soins.

2.9 Assurance facultative d'indemnités journalières

L'assurance facultative d'indemnités journalières peut être signée par toute personne domiciliée en Suisse ou qui y exerce une activité lucrative, âgée de quinze ans révolus, mais qui n'a pas atteint 65 ans. Elle peut, à cet effet, choisir un autre assureur que celui de l'assurance obligatoire des soins. Elle se présente sous la forme d'une **assurance individuelle ou collective**.

Des réserves sont possibles, car les assureurs peuvent **exclure de l'assurance, par une clause de réserve, les maladies existant au moment de l'admission**. Il en va de même pour les maladies antérieures si, selon l'expérience, une rechute est possible. Les réserves sont **caduques au plus tard après cinq ans**. Avant l'échéance de ce délai, l'assuré peut fournir la preuve que la réserve n'est plus justifiée. La réserve est communiquée par écrit à l'assuré et précise le début et la fin de sa validité ainsi que le type de maladie qu'elle concerne.

L'assureur convient avec le preneur d'assurance **du montant des indemnités journalières assurées**. Le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque l'assuré a une capacité de travail réduite au moins de moitié. A défaut d'accord contraire, le droit prend naissance le troisième jour qui suit le début de la maladie. Le versement des prestations peut être différé moyennant une réduction correspondante du montant de la prime. Les indemnités journalières doivent être versées, pour une ou plusieurs maladies, durant au moins 720 jours.

Réseaux de soins intégrés

Le HMO (*Health Maintenance Organisation*) correspond à **un lieu physique** dans lequel travaillent plusieurs professionnels de santé. Les HMO sont généralement gérés par les assureurs et les professionnels sont souvent salariés. Il n'y a pas de libre choix du médecin, mais cela permet **une réduction de primes**.

Les réseaux sont formés de plusieurs médecins de premier recours avec un rôle de « *gate keeping* ». Cela permet **d'éviter des consultations spécialisées parfois non nécessaires**. Un réseau peut être géré par les assureurs (souvent) **ou par des médecins** (ex. Delta à GE/VD). Des **économies sont réalisées** grâce à une meilleure gestion et une meilleure utilisation des médicaments. De plus, il y a une obligation de formation continue et de cercles de qualité. Finalement, on note la possibilité d'une offre **de médecine préventive** pour les affiliés au réseau.

Les réseaux de soins intégrés posent cependant quelques **difficultés éthiques**. Ce type d'assurance est prisée par **les assurés jeunes et en bonne santé** qui peuvent sans difficultés assumer la restriction de liberté inhérente au réseau durant 15 ans (économie financière importante) et en sortir ensuite, ce qui crée une **"entorse au principe de solidarité"**. En plus, il faut se rappeler qu'en cas de situation financière précaire, une personne n'opère pas un choix libre et éclairé. Finalement, dans les modèles discutés, il reste encore à régler **la question de la pénalisation ou de l'incitation financière** (ex. quote-part augmentée à 20% en cas de refus du réseau).

Récapitulatif.

	Soins intégrés (art. 41c)	Modèles alternatifs d'assurances (art. 41b, al. 2)	Assurance de base actuelle
Caractéristiques	Réseaux de soins intégrés avec régulation des processus de traitement des assurés à travers toute la filière de traitement	Contrats individuels de médecins de famille, sans coresponsabilité budgétaire, offres de télémedecine, liste de produits	
Contrat spécial entre médecins et assureurs	Oui	Non (excepté pour les contrats individuels de médecins de famille)	Non
Coresponsabilité budgétaire	Oui	Non	Non
Prestations médicales	Potentiellement davantage que dans le catalogue des prestations	Catalogue des prestations	Catalogue des prestations
Primes	Réduites	Réduites	Normales
Quote-part	Plafond à 10% (ou moins)	20%	20%
Montant maximal (de la compétence du CF)	500 francs (?)	1000 francs (?)	1000 francs (?)